

Czym jest *OCPD*

Anankastyczne zaburzenie osobowości — perfekcjonizm i potrzeba kontroli, które zaczynają kosztować więcej, niż dają.

CZAS: 15 min Karta orientacyjna

ŹRÓDŁO: DSM-5-TR (APA, 2022); ICD-11 (WHO, 2022); Beck, Davis & Freeman (2015)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **8 cech** poniżej. Zaznacz te, które rozpoznajesz u siebie z ostatnich kilku lat — nie z jednego trudnego tygodnia. Wzorec OCPD jest **trwały i sztywny**, obecny w pracy, w domu i w relacjach. Diagnozę stawia klinicysta — ta karta służy do *rozumienia*, nie do samodzielnego rozpoznania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

OCPD nie jest „byciem dokładnym”. To wzorec, w którym **standardy i kontrola wyprzedzają cel** — zadanie nie zostaje skończone, bo nie jest „idealne”, a relacje cierpią, bo wszystko musi być po jednym, właściwym sposobie. Najtrudniejsze: cechy są *egosyntoniczne* (ang. *ego-syntonic*) — wydają się słuszne, więc cierpienie częściej zgłaszają bliscy niż sama osoba.

01 Osiem cech — do rozpoznania wystarczą cztery

Klinicysta rozpoznaje OCPD, gdy obecne są co najmniej **4 z 8** trwałych cech (DSM-5-TR). Zaznacz ☐ te, które do Ciebie pasują.

☐ 1 · Szczegóły i porządek

Listy, reguły, harmonogramy tak ważne, że *gubi się sam cel działania*.

☐ 2 · Perfekcjonizm

Standardy tak wysokie, że *przeszkadzają w skończeniu* zadania.

☐ 3 · Praca ponad wszystko

Praca i produktywność kosztem odpoczynku, przyjaźni i relacji.

☐ 4 · Sztywna moralność

Nadmierna sumienność, brak elastyczności w kwestiach zasad i wartości.

☐ 5 · Trudność z wyrzucaniem

Trzymanie zużytych, bezwartościowych rzeczy „na wszelki wypadek”.

☐ 6 · Niechęć do delegowania

„Zrobię sam/-a” — chyba że inni robią dokładnie po moim sposobie.

☐ 7 · Skąpstwo

Oszczędzanie wobec siebie i innych; pieniądze trzymane na przyszłą katastrofę.

☐ 8 · Sztywność i upór

Trudność z ustępowaniem, zmianą zdania i dopuszczeniem cudzego sposobu.

02 Dlaczego tak trudno to u siebie zauważyć

W większości problemów psychicznych objaw jest *obcy* — lęk, smutek czy natrętna myśl przeszkadzają i chce się ich pozbyć. W OCPD jest odwrotnie: cechy wydają się **słuszne i potrzebne**. To nazywamy *egosyntonią* — wzorec zlewa się z poczuciem „taki/-a po prostu jestem”.

Dlatego sygnał ostrzegawczy często przychodzi **z zewnątrz**: to partner mówi „nigdy nie odpoczywasz”, to dziecko unika wspólnego gotowania, to zespół boi się oddać Ci projekt. *Cudza reakcja bywa lepszym wskaźnikiem niż własne poczucie słuszności*.

03 Zdrowa sumienność a OCPD — gdzie przebiega granica

Dokładność, ambicja i odpowiedzialność to mocne strony. OCPD zaczyna się tam, gdzie te cechy przestają służyć — **kosztują więcej, niż dają**, a Ty nie możesz ich odpuścić, nawet gdy chcesz.

ZDROWA SUMIENNOŚĆ

Standard **dopasowany do stawki** — e-mail nie musi być doskonały, operacja tak.
Mogę *odpuścić*, gdy korzyść maleje.
Cieszę się efektem.
Zostaje czas na życie poza zadaniem.

WZORZEC OCPD

Ten sam **maksymalny standard do wszystkiego** — bez względu na stawkę.
Nie potrafię odpuścić, choć wiem, że szkodzi.
Po skończeniu — ulga, nie radość.
Życie kurczy się do obowiązków.

04 Co pomaga — i czego ta zmiana NIE oznacza

Terapia OCPD nie polega na „odpuszczeniu sobie” ani na staniu się niechlujnym/-ą. Chodzi o **elastyczność**: zachować wysokie standardy tam, gdzie mają sens, i świadomie je obniżyć tam, gdzie kosztują zdrowie, relacje i radość.

Standard „wystarczająco dobre”

dopasowanie wysiłku do stawki zadania.

Elastyczność reguł

jeden sposób zamieniony na „jeden z możliwych”.

Praca ze schematami

skąd wzięły się „muszę być idealny/-a”.

Klucz: OCPD to najczęstsze zaburzenie osobowości w populacji ogólnej (ok. 2-8%; APA, 2022). Terapia poznawczo-behawioralna i terapia schematów mają tu dobre podstawy — celem nie jest „mniej się starać”, lecz *odzyskać wybór*: móc czasem zrobić rzecz na 80%, oddać kontrolę i odpocząć bez poczucia winy.